

17. L'ŒIL ET LE MOUVEMENT DE CORTICALISATION

DURÉE : 08:22

FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Cette vidéo explore le lien dynamique entre l'œil et le mouvement de corticalisation dans le développement du cerveau. Le processus de flexion céphalique et cervicale est examiné, ainsi que la réorganisation des tissus cérébraux en relation avec les structures faciales et viscérales. L'œil est présenté comme un acteur central dans ce mouvement, influençant la formation de la faux du cerveau et de la tente du cervelet, tout en intégrant des aspects psychiques et émotionnels à travers son lien avec le système hormonal. Les concepts de diaphragme d'équilibre et de fulcrum terminal sont introduits, soulignant l'importance de la stabilisation des suture crissiforme pour rééquilibrer les yeux et favoriser l'harmonie corporelle. Cette leçon offre des clés pratiques et théoriques pour les praticiens désireux de mieux appréhender le développement embryologique et ses implications thérapeutiques.

L'ŒIL ET LE MOUVEMENT DE CORTICALISATION

Le **cerveau**, initialement perçu comme un tissu plat, subit une transformation significative au cours de son développement. Imaginez un individu allongé sur une table, avec son cerveau en main. La première information à retenir est celle de l'**expansion** et de la **formation du tube neural**.

Ce processus commence par un **mouvement de flexion céphalique**, suivi d'une **flexion cervicale**, puis d'un développement **pontique** et d'un processus de **télencéphalie**. À mesure que le cerveau se redresse, les petites structures suivent ce mouvement de développement, indiquant un changement d'orientation.

L'**œil**, dans sa spirale de développement, contient l'information de la **corticalisation**. Lors de ce redressement, tout le tissu se réorganise dans un mouvement de rotation, se rapprochant de la **ligne médiane**. En bas, le tissu tire vers le cœur et le système digestif, tandis qu'en haut, il se redresse. Ce mouvement est créé par l'**ascension du cerveau** et la **descente du cardio-viscéral**.

L'œil joue un rôle crucial dans ce phénomène de **corticalisation**, contribuant au développement de la **faux du cerveau** et de la **tente du cervelet**, qui s'insère sur les processus clinoïdes. À proximité se trouve le **chiasma optique**, un élément essentiel à prendre en compte.

Un autre aspect important est le **diaphragme de l'équilibre** et la **capsule de Tonon**, qui relie l'œil à l'ensemble du système facial et à tous les fascias du corps. Cela signifie que l'œil constitue une **unité** intégrale, contenant toute l'information faciale. Il reçoit également des informations émotionnelles et psychiques, véhiculées par des substances hormonales. Ainsi, l'état psychique est intrinsèquement lié à un état hormonal et émotionnel.

Traiter l'œil, c'est donc aborder le développement à la fois **péritonéal, périphérique** et **cortical**. L'œil est en relation avec la totalité du corps dans son expression et son développement. Chaque organe possède son propre point de vue, et chaque organe est un symbole.

Aux environs du **26e jour**, un **sillon optique** apparaît, lié à une connexion interne. Ce sillon est stimulé par une vésicule qui touche la paroi superficielle.

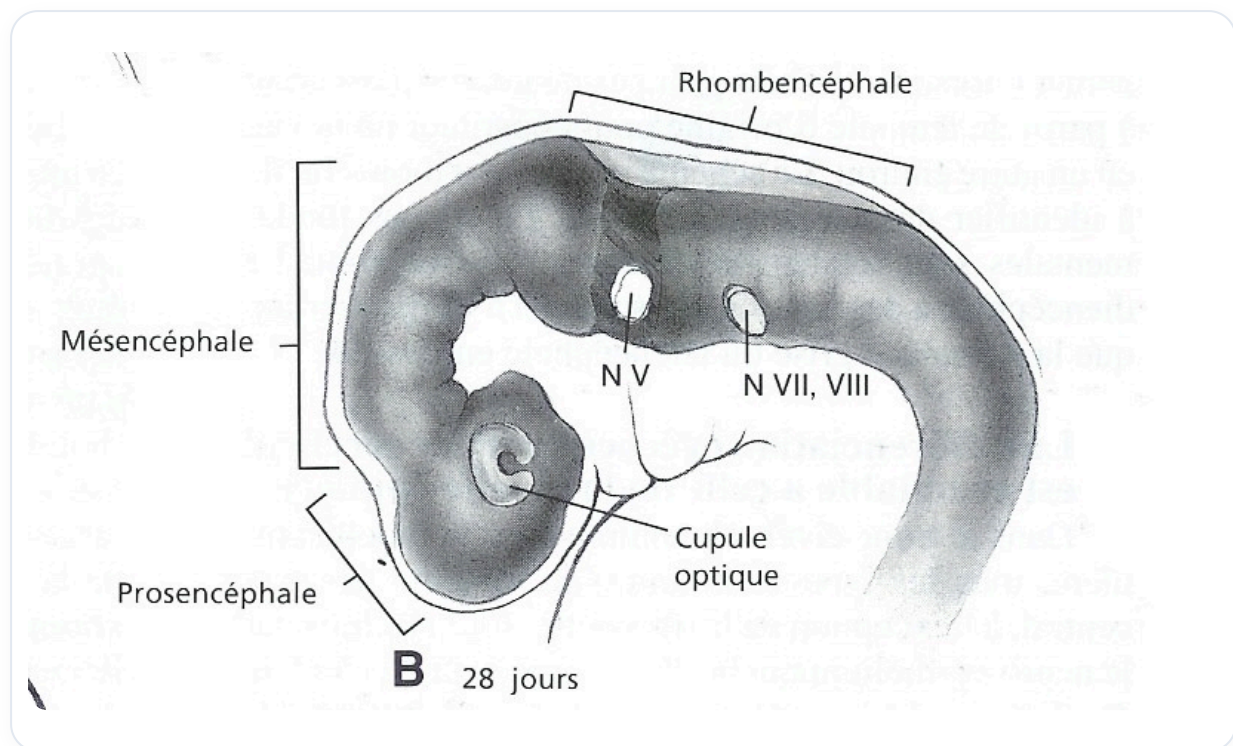


FIG. — *Sillon optique et vésicule*

La flexion céphalique et cervicale entraîne une rencontre entre le cerveau et le cœur, avec l'œil se déposant sur le cœur.

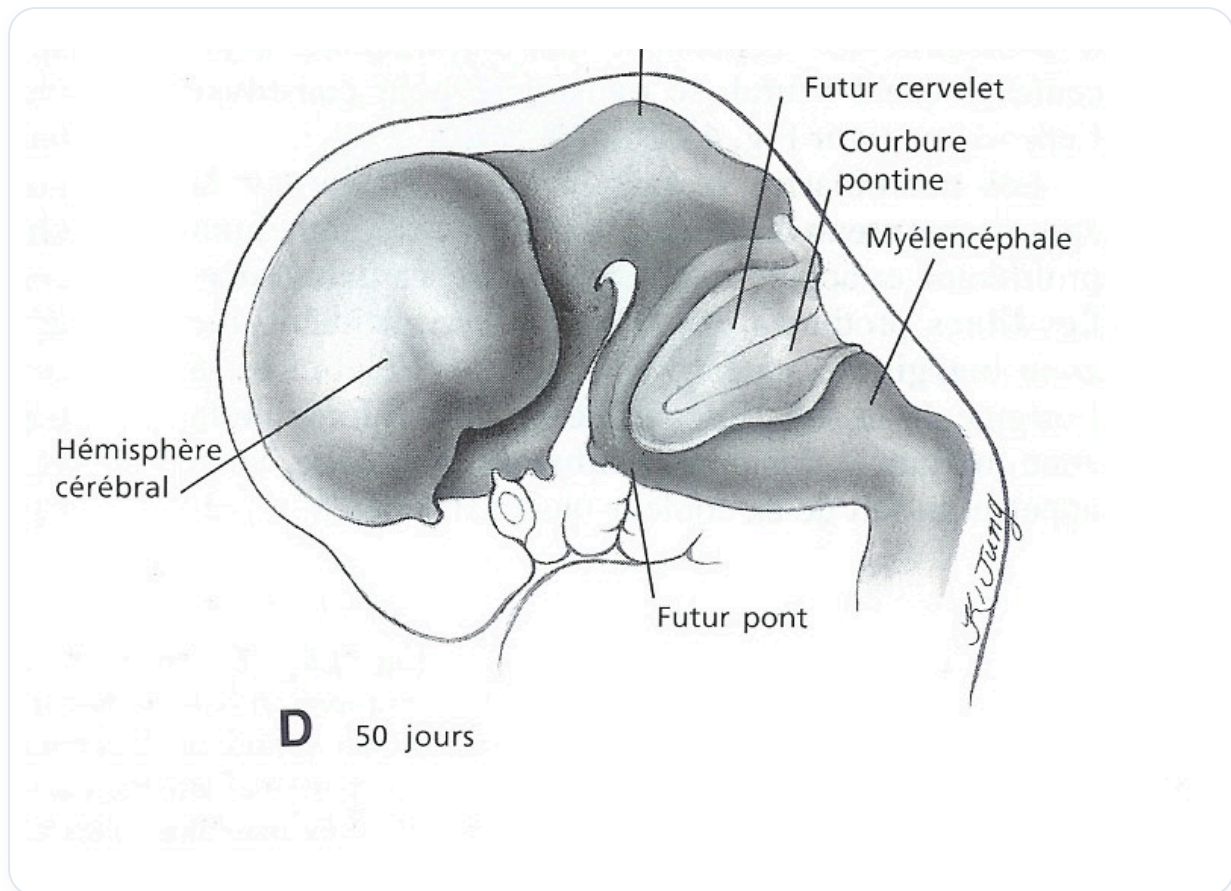


FIG. — Rencontre du cerveau et du cœur

Cela crée un **pli postérieur**, connu sous le nom de **courbure pontique**, où se trouve le sacrum et la tente du cervelet.

La **tente du cervelet** est primordiale, car elle établit des synchronicités avec le péritoine et le cerveau. La **flexure submésencéphale** est en rapport avec la pointe de la **notocorde**, servant de point d'appui. Le **supraocciput** est également lié à la flexion cervicale, tandis que la flexure pontique est associée à la base occipitale.

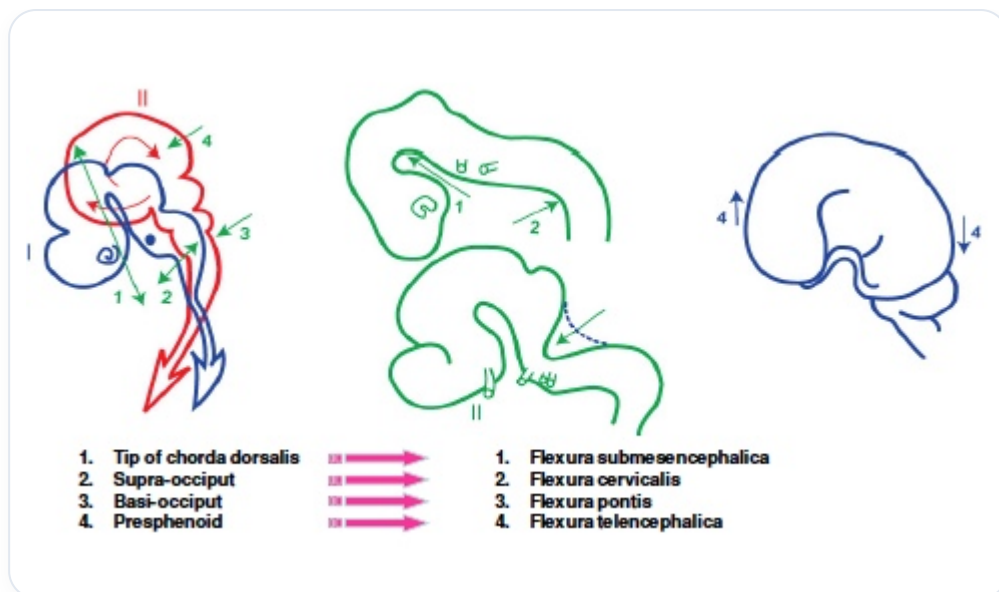


FIG. — Points d'appui

L'ascension du tube neural influence le développement du système digestif et cardiaque, ainsi que d'autres espaces de développement. Les **colocalités** et **synchronicités** durant la morphogenèse aident à comprendre les points d'appui. L'ascension de l'**ectoderme** et la descente de l'**endoderme** sont essentielles pour l'intégration du cerveau.

L'œil suit cette phase de développement, se rapprochant de la ligne médiane pour former la **cristagalie**, qui réunit les membranes pour créer la faux du cerveau. La tente du cervelet se développe également durant le phénomène de pontisation.

Il est crucial de noter que le point d'appui, ou **fulcrum terminal**, de la mise en place des yeux est essentiel. Pour rééquilibrer les yeux, il est recommandé de placer un doigt dans la bouche, au niveau de la petite **suture crissiforme**. Cela permet aux deux yeux de trouver leur espace au moment où cette suture se stabilise.

La **margelle frontale**, la **margelle zygomatique** et la **margelle maxillaire supérieure** sont des points d'appui importants. La montée et la descente des structures contribuent à la fermeture de la ligne médiane, ce qui est également lié à la fermeture du palais. Lorsque le palais trouve son point d'appui, les yeux trouvent également leur place, marquant un **fulcrum d'arrivée** dans le développement.